

Monograf
**PERAN KELUARGA
DALAM PERAWATAN
PENDERITA TB PARU**

Domianus Namuwali
Maria Kareri Hara
Aemilianus Mau

Buku Monograf
PERAN KELUARGA
DALAM PERAWATAN
PENDERITA TB PARU

Domianus Namuwali, S.Kep., Ns., M.Kep.

Maria Kareri Hara, S.Kep.,Ns.,M.Kes.

Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Monograf
Peran Keluarga Dalam Perawatan Penderita TB Paru

Domianus Namuwali., S.Kep., Ns., M.Kep.

Maria Kareri Hara, S.Kep.,Ns.,M.Kes.

Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Achmad Faisal

ISBN: 978-623-10-9833-7

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram @bimbel.optimal

Tiktok @maskokooo

www.optimaluntuknegeri.com

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



Prakata

Penulis Patut menaikkan Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pertolongan dan Perlindungan-Nya sehingga penulisan buku yang berjudul **'Peran Keluarga dalam Perawatan Penderita TB Paru'** dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan bentuk kontribusi penulis dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan keluarga dalam proses perawatan penderita Tuberkulosis Paru (TB Paru), terutama di tingkat rumah tangga.

Tuberkulosis masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang membutuhkan prioritas utama di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dalam menghadapi penyakit ini, peran keluarga tidak dapat diabaikan. Keluarga, terutama keluarga inti, merupakan lingkungan terdekat yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi fisik, emosional, dan sosial penderita. Sayangnya, pada kenyataannya peran keluarga masih sering kali bersifat parsial dan belum dilakukan secara menyeluruh.

Melalui buku ini, penulis mencoba menyajikan berbagai bentuk peran keluarga dalam mendampingi penderita TB Paru, mulai dari peran dalam mengatasi keluhan batuk, upaya pencegahan penularan, modifikasi lingkungan, mendampingi saat kontrol rutin, hingga peran dalam menjaga kepatuhan minum obat dan memberikan motivasi. Seluruh pembahasan dilengkapi dengan hasil wawancara langsung dari informan serta dukungan data dari berbagai literatur dan penelitian terdahulu.

Penulis memiliki harapan yang besar, semoga buku ini dapat menjadi sumber informasi sekaligus inspirasi bagi tenaga kesehatan,

mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami betapa krusialnya keterlibatan keluarga dalam proses pengobatan TB Paru. Selain itu, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam pengembangan intervensi keperawatan berbasis keluarga yang lebih efektif di Indonesia untuk mendukung program pengendalian TB.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang sudah memberikan bantuan dan dukungan baik dalam bentuk moril maupun material selama penyusunan dan penyelesaian buku ini. Penulis juga menantikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Mei, 2025

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iv
Daftar Isi	vi
BAB 1 Pendahuluan.....	1
BAB 2 Konsep Penyakit TB Paru	6
A. Pengertian Penyakit TB Paru	6
B. Penyebab Penyakit TB Paru	7
C. Penularan Tuberkulosis.....	8
D. Faktor Risiko.....	9
E. Gejala Klinis Penyakit TB Paru	10
F. Klasifikasi dan Tipe	10
G. Pengobatan	14
H. Pencegahan Penyakit TB Paru.....	17
I. Komplikasi.....	18
BAB 3 Konsep Keluarga	19
A. Pengertian Keluarga.....	19
B. Ciri-Ciri Keluarga	20
C. Tipe Keluarga	20
D. Struktur Keluarga	30
E. Fungsi Keluarga	32
F. Tugas Keluarga di Bidang Kesehatan.....	33
G. Sistem Keluarga	33
H. Peran Keluarga	34
I. Tugas Perkembangan Sesuai Dengan Tahap Perkembangan (Duval) (<i>Sociological Perspective</i>)	35

BAB 4 Peran Keluarga Dalam Perawatan Penderita	
TB Paru.....	38
A. Karakteristik.....	38
B. Peran Keluarga dalam Perawatan Penderita TB	
Paru.....	40
BAB 5 Penutup.....	56
 Daftar Pustaka	 59
Glosarium	65
Profil Penulis	68



BAB 1

Pendahuluan

Tuberkulosis (TB) adalah Penyakit menular yang dapat menyerang berbagai organ tubuh manusia, seperti otak, ginjal, dan tulang belakang, namun paru-paru merupakan organ yang paling sering terdampak. Bakteri penyebab TB, yaitu *Mycobacterium tuberculosis*, merusak jaringan paru-paru. Penularan Tuberkulosis Paru (TB Paru) terjadi melalui udara, ketika penderita melepaskan droplet yang mengandung kuman saat batuk, bersin, atau berbicara, yang kemudian terhirup oleh orang lain di sekitarnya (Smeltzer, Suzanne C. dan Bare, 2002).

Penyakit Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu dari sepuluh penyebab utama kematian di dunia, sekaligus merupakan penyebab kematian tertinggi dari kelompok penyakit infeksi. Menurut *World Health Organization* (WHO, 2019), pada tahun 2018 diperkirakan terdapat sekitar 10 juta kasus TB paru secara global, dengan angka kematian menyentuh angka 1,2 juta jiwa.

Kira-kira 57% dari penderita TB paru merupakan laki-laki. Distribusi kasus terbesar tercatat di Asia Tenggara (44%), diikuti oleh Afrika (24%) dan Pasifik Barat (18%).

Sebanyak delapan negara dengan beban TB terbanyak adalah: India (27%), Cina (9%), Indonesia (8%), Filipina (6%), Pakistan (6%), Nigeria (4%), Bangladesh (4%) dan Afrika Selatan (3%). Di Indonesia sendiri, pada tahun 2018 terdapat 265 juta penduduk dengan 511.873 kasus TB pada semua tipe, dan 203.348 kasus TB Paru terkonfirmasi dari hasil pemeriksaan bakteriologis (Hardhana et al., 2018).

Khusus di Kabupaten Sumba Timur, Data dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah penderita Tuberkulosis Paru (TB Paru) pada tahun 2016 mencapai 459 orang, meningkat menjadi 556 orang pada tahun 2017. Namun, jumlah tersebut menurun menjadi 408 orang di tahun 2018 dan kembali turun menjadi 398 orang pada tahun 2019. Sementara itu, di wilayah kerja Puskesmas Kambaniru, jumlah kasus TB Paru tercatat sebanyak 68 orang pada tahun 2016 dan 2017, kemudian Angka TB Par terus berkurang hingga mencapai angka 58 orang pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 terus mengalami penurunan kasus TB Paru hingga mencapai angka 38 orang pada tahun 2019 (Dinkes Sumba Timur, 2016, 2017, 2019).

Menurut pengelola TB Paru Puskesmas Kambaniru, pada tahun 2024 terdapat satu kasus pasien rujukan dari RSUD Umu Meha yang putus obat dan beralih ke pengobatan herbal. Hal ini menjadi indikator adanya pasien yang tidak patuh dalam menjalani pengobatan, yang berisiko menyebabkan kegagalan pengobatan dan peningkatan potensi resistensi obat.

Pengobatan TB memerlukan ketekunan dan kepatuhan pasien untuk mengonsumsi obat minimal selama enam bulan secara teratur. Ketidakpatuhan menyebabkan risiko tidak sembuh, timbulnya kuman yang kebal obat, serta meningkatnya biaya pengobatan (Kemenkes RI, 2018).

Salah satu tantangan besar dalam pengendalian TB adalah munculnya TB dengan resistensi terhadap berbagai jenis obat, yang sering kali disebabkan oleh ketidakpatuhan pasien terhadap regimen pengobatan (Makhfudli, 2019). Penelitian Badan Litbangkes (Fadila & Riono, 2014) menyebutkan bahwa Salah satu unsur yang berkontribusi pada rendahnya angka kesembuhan adalah ketidakpatuhan terhadap aturan pengobatan TB Paru.

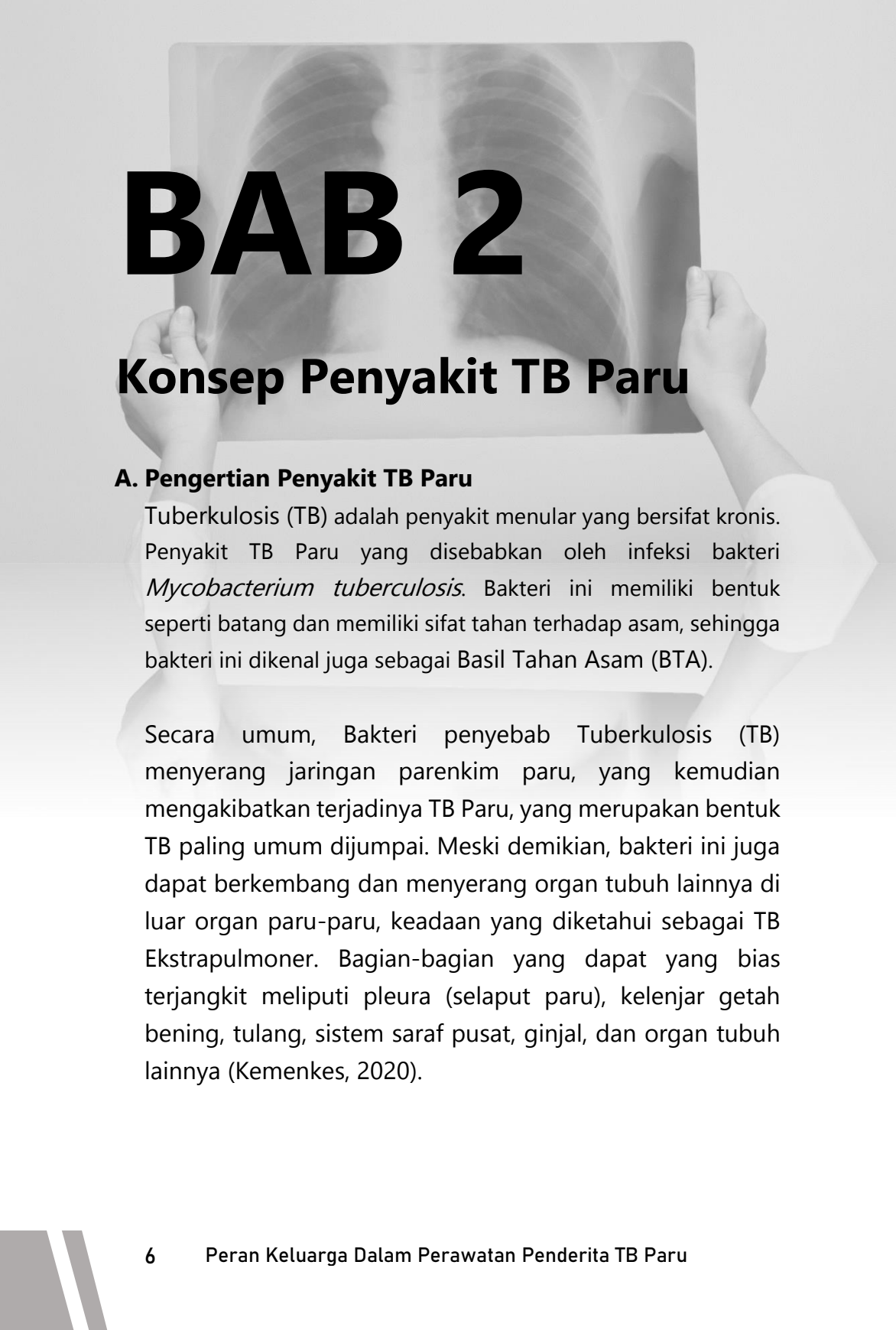
Randy (2011) menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab pasien drop out dari pengobatan antara lain: merasa sembuh karena gejala menghilang setelah tahap intensif, biaya pengobatan yang tidak sepenuhnya gratis, ketidaktahuan mengenai urutan pengobatan penyakit TB Paru, Pengawas Menelan Obat (PMO) yang tidak ada, kendala transportasi,

reaksi samping obat, serta ketidakpahaman tentang penyulit penyakit TB. Pada Kondisi ini, peran keluarga menjadi sangat menentukan untuk mendukung keberhasilan pengobatan pasien TB (Nugroho Adhi Randy, 2011).

Keluarga dapat memberikan dukungan fisik, psikologis, serta menjadi PMO. Penelitian oleh Kristinawati et al. (2019) menegaskan pentingnya dukungan keluarga dalam perawatan TB, baik secara fisik maupun emosional (Kristinawati et al., 2020). Jufrizal, Hermansyah, dan Mulyadi (2016), serta Dary et al. (2018) juga menyebutkan bahwa Peran keluarga sebagai Pengawas Minum Obat (PMO) sangat menentukan keberhasilan pengobatan, terutama pada anak-anak yang terjangkit Tuberkulosis Paru (TB Paru), mengingat kepatuhan minum obat secara teratur merupakan kunci utama dalam proses penyembuhan (Dary et al., 2018; Jufrizal, Hermansyah, 2016).

Motivasi dari keluarga turut mempengaruhi kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan hingga tuntas (Dary et al., 2018). Oleh karena itu, peran aktif keluarga sebagai pendukung utama sangat diperlukan dalam mendukung proses penyembuhan pasien Tuberkulosis Paru (TB Paru), baik dari segi pengawasan pengobatan maupun dukungan psikososial (Dary et al., 2018).

Mengacu uraian diatas, penulis berminat untuk mempelajari lebih mendalam mengenai peran keluarga dalam memberikan perawatan kepada pasien Tuberkulosis Paru (TB Paru), dengan fokus pada bagaimana keterlibatan keluarga perawatan penderita TB Paru.



BAB 2

Konsep Penyakit TB Paru

A. Pengertian Penyakit TB Paru

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang bersifat kronis. Penyakit TB Paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Bakteri ini memiliki bentuk seperti batang dan memiliki sifat tahan terhadap asam, sehingga bakteri ini dikenal juga sebagai Basil Tahan Asam (BTA).

Secara umum, Bakteri penyebab Tuberkulosis (TB) menyerang jaringan parenkim paru, yang kemudian mengakibatkan terjadinya TB Paru, yang merupakan bentuk TB paling umum dijumpai. Meski demikian, bakteri ini juga dapat berkembang dan menyerang organ tubuh lainnya di luar organ paru-paru, keadaan yang diketahui sebagai TB Ekstrapulmoner. Bagian-bagian yang dapat yang bias terjangkit meliputi pleura (selaput paru), kelenjar getah bening, tulang, sistem saraf pusat, ginjal, dan organ tubuh lainnya (Kemenkes, 2020).

Tuberkulosis umumnya menyerang paru-paru sebagai organ utama sebelum menyebar ke bagian tubuh lainnya. Setelah paparan awal, infeksi biasanya berlangsung secara laten selama 2 hingga 10 minggu. Dalam fase ini, sistem imun tubuh berusaha mengendalikan bakteri, dan sebagian besar individu belum menunjukkan gejala klinis.

Setelah melewati masa tersebut, pasien dapat mulai mengalami gejala akibat gangguan fungsi paru dan respon imun yang tidak efektif. Aktivasi penyakit TB bisa terjadi secara perlahan dan dalam jangka panjang. Perjalanan penyakit ini umumnya ditandai oleh fase remisi, yaitu periode ketika penyakit berhasil ditekan oleh sistem imun dan tidak menunjukkan gejala aktif. Namun, TB dapat kembali aktif sewaktu-waktu, terutama jika daya tahan tubuh menurun (Wahdi & Puspitosari, 2021).

B. Penyebab Penyakit TB Paru

Penyebab penyakit Tuberkulosis (TB) adalah *Mycobacterium tuberculosis*. Selain *M. tuberculosis*, terdapat beberapa spesies lain dari kelompok *Mycobacterium* yang juga dapat menyebabkan infeksi, diantaranya *M. africanum*, *M. bovis*, dan *M. leprae*. Semua spesies ini terkenal sebagai bakteri/kuman tahan asam (BTA) karena kemampuannya untuk bertahan terhadap pewarnaan asam dan alkali dalam pewarnaan mikroskopik, "jenis bakteri *Mycobacterium* selain *Mycobacterium tuberculosis* yang dapat mengakibatkan gangguan pada saluran pernapasan dikenal sebagai MOTT (*Mycobacterium*

Other Than Tuberculosis). kuman ini kadang-kadang dapat menyulitkan dalam proses penegakan diagnosis dan pengobatan karena gejalanya yang mirip dengan Tuberkulosis Paru (Kemenkes RI, 2014)

C. Penularan Tuberkulosis

1. Sumber Penularan

Pasien Tuberkulosis Paru (TB) dengan hasil BTA positif merupakan sumber utama penularan, karena mereka mengeluarkan percikan renik dahak (droplet nuclei) yang mengandung *Mycobacterium tuberculosis* saat batuk atau bersin. Namun, tidak berarti juga bahwa pasien TB Paru dengan hasil dahak BTA negatif tidak dapat menularkan kuman pada orang lain. Hasil BTA negatif bisa terjadi jika jumlah kuman dalam sampel dahak < 5.000 kuman per cc, sehingga tidak terdeteksi dalam pemeriksaan mikroskopis.

2. Tingkat Penularan

Meskipun BTA negatif, pasien TB tetap dapat menularkan penyakit, tergantung pada hasil kultur dan foto toraks. Tingkat penularan berdasarkan jenis pemeriksaan adalah:

- a. Pasien TB dengan BTA positif: 65%
- b. Pasien TB dengan BTA negatif namun hasil kultur/biakan positif: 26%
- c. Pasien TB dengan hasil kultur/biakan negatif dan foto toraks positif: 17%

3. Mekanisme Penularan

Infeksi Tuberkulosis (TB) terjadi ketika seseorang menghirup percikan renek dahak (droplet nuclei) yang memiliki *Mycobacterium tuberculosis* dari penderita TB yang mengalami batuk atau bersin.

4. Percikan Dahak Saat Batuk

Ketika batuk atau bersin, pasien dapat mengeluarkan kuman *Mycobacterium tuberculosis* di udara dalam berupa percikan renek dahak. Satu kali batuk bisa mengeluarkan sekitar 3.000 percikan dahak yang mengandung kuman TB. (Kemenkes RI, 2014).

D. Faktor Risiko

Terdapat beberapa kelompok yang berisiko tinggi terhadap penyakit Tuberkulosis Paru (TB Paru), antara lain:

1. Pengidap *HIV AIDS* dan penyakit Imunodefisiensi lainnya.
2. Individu yang minum obat obat imunosupresan dalam durasi lama.
3. Perokok.
4. Pengguna alcohol yang berlebihan.
5. Balita dan lansia.
6. Seseroang yang sentuhan erat dengan penderita TB aktif terjangkit.
7. Individu yang tinggal atau bekerja di lingkungan dengan potensi penularan Tuberkulosis yang tinggi, seperti lembaga pemasyarakatan(LP) atau fasilitas layanan perawatan jangka panjang.

8. Tenaga Medis dan kesehatan yang berisiko tinggi terpapar penderita TB (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020)

E. Gejala Klinis Penyakit TB Paru

Manifestasi klinis penyakit Tuberkulosis (TB) ditentukan oleh pada lokasi lesi, dan dapat memperlihatkan gejala klinis sebagai berikut:

1. Batuk yang berlangsung > 2 minggu.
2. Batuk disertai lender.
3. Batuk berlendir yang dapat disertai darah.
4. Sakit dada.
5. Sulit bernapas.

Gejala lainnya meliputi:

1. Malaise (rasa tidak enak badan).
2. Berat badan menurun.
3. selera nafsu makan.
4. Demam.
5. Badan keringat pada malam hari (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

F. Klasifikasi dan Tipe

Diagnosis Tuberkulosis (TB) dengan tervalidasi bakteriologis atau klinis dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Kemenkes, 2020):

1. Berdasarkan anatomi

a. TB paru

Infeksi Tuberkulosis (TB) yang muncul pada jaringan parenkim paru disebut sebagai TB Paru. TB milier dikategorikan sebagai TB Paru karena munculnya lesi pada jaringan paru-paru. Sementara itu, limfadenitis TB pada rongga toraks (hilus dan/atau mediastinum) atau efusi pleura tanpa disertai bukti radiologi TB Paru, diklasifikasikan sebagai TB Ekstra Paru. Jika seorang pasien mengalami TB Paru sekaligus TB Ekstra Paru, maka pasien tersebut tetap dikelompokkan sebagai pasien TB Paru

b. TB ekstra paru

Merupakan tuberkulosis yang menginfeksi bagian tubuh di luar paru, seperti pleura, kelenjar getah bening, rongga perut, saluran kemih, kulit, sendi, selaput otak, dan tulang. Diagnosis TB paru dapat didiagnosis melalui pemeriksaan bakteriologis maupun klinis, dengan upaya utama mengkonfirmasi keberadaan *ycobacterium tuberculosis*. Jika TB menyerang beberapa organ sekaligus, maka pasien diklasifikasikan berdasarkan organ yang mengalami kerusakan paling parah.

2. Berdasarkan riwayat pengobatan

a. Pasien baru

Penderita yang tidak pernah menjalani pengobatan TB sebelumnya atau yang telah

- mengonsumsi obat anti-TB (OAT) < 1 bulan (<28 dosis).
- b. Pasien yang sudah mengalami pengobatan TB
Pasien yang telah mengonsumsi OAT Dalam Jangka waktu satu bulan atau lebih (>28 dosis). Kelompok ini kemudian di kategorikan berdasarkan hasil pengobatan terakhir yang dijalani.
 - c. Pasien kambuh (*relaps*)
Pasien yang sebelumnya telah ditetapkan sembuh atau telah menyelesaikan pengobatan, tetapi dinyatakan menderita TB berdasarkan hasil pemeriksaan bakteriologis atau klinis, baik akibat ke kambuhan sebenarnya maupun infeksi. Pasien yang diobati kembali setelah gagal merupakan pasien yang sebelumnya telah menjalani pengobatan Tuberkulosis (TB), tetapi dinyatakan gagal dalam terapi tersebut.
 - d. Pasien yang di obati kembali setelah putus berobat
Pasien yang sebelumnya telah menjalani pengobatan tetapi sempat berhenti (*lost to follow-up*). klasifikasi ini sebelumnya dikenal sebagai pasien yang menjalani pengobatan sesudah berhenti mengonsumsi obat (*default*).
 - e. Kategori lain
Pasien yang sudah mengalami pengobatan TB tetapi hasil akhir terapynya tidak teridentifikasi.

3. Berdasarkan uji kepekaan terhadap obat
 - a. TB *mono resisten* (TB MR)
TB yang kebal pada satu jenis OAT lini pertama.
 - b. TB *poli resisten* (TB PR)
TB yang menunjukkan resistensi pada lebih dari satu OAT lini pertama, kecuali isoniazid (H) dan rifampisin (R) secara sekaligus.
 - c. TB *multi drug resisten* (TB MDR)
TB yang resisten terhadap isoniazid (H) dan rifampisin (R) sekaligus.
 - d. TB *extensive drug resisten* (TB XDR)
TB MDR yang juga resisten pada salah satu obat golongan fluorokuinolon serta paling kurang satu jenis OAT lini kedua yang diberikan melalui injeksi, seperti kanamisin, kapreomisin, atau amikasin.
 - e. TB *resisten rifampisin* (TB RR)
TB yang memiliki resistensi terhadap rifampisin, baik dengan atau tanpa resistensi terhadap OAT lainnya, yang teridentifikasi melalui teknik fenotip (konvensional).
4. Berdasarkan status HIV pasien
 - a. Pasien TB dengan HIV positif
Pasien yang terdiagnosis TB dan memiliki hasil tes HIV positif, baik dari pemeriksaan sebelumnya maupun saat ini, atau sedang menjalani terapi *antiretroviral* (ART).

- b. Pasien TB dengan HIV negatif
Pasien yang terdiagnosis Tuberkulosis (TB) namun memiliki hasil tes HIV negatif, baik dari pemeriksaan sebelumnya maupun saat ini. Catatan: Jika pada pemeriksaan selanjutnya hasil tes HIV menunjukkan hasil positif, maka pasien harus diklasifikasikan ulang sebagai pasien TB dengan HIV positif.
- c. Pasien TB dengan status HIV tidak diketahui
Pasien Tuberkulosis (TB) yang belum memiliki bukti hasil tes HIV saat diagnosis TB ditegakkan. Catatan: Jika hasil tes HIV pasien diketahui kemudian, maka klasifikasinya harus diperbarui sesuai dengan hasil tes terbaru (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

G. Pengobatan

1. Tahap pengobatan

Penanganan penyakit Tuberkulosis (TB) wajib mengikuti prosedur pengobatan tahap awal dan tahap lanjutan, dengan tujuan untuk memastikan penyembuhan yang optimal, mencegah resistensi obat, serta mengurangi risiko penularan, tahap pengobatan TB Paru terdiri dari:

a. Tahap awal

Pengobatan Tuberkulosis (TB) minum setiap hari. Panduan therapy fase awal bertujuan agar memberikan dampak untuk menurunkan jumlah kuman *Mycobacterium tuberculosis* di dalam tubuh orang yang terjangkit TB Paru dan meminimalkan dampak

dari sejumlah kecil bakteri yang mungkin sudah kebal pada sebelum dimulainya pengobatan. Pengobatan tahap awal pada semua pasien baru harus diberikan selama 2 bulan. Secara umum, dengan pengobatan yang teratur dan tanpa adanya faktor penyulit, daya penularan sudah sangat berkurang setelah 2 minggu pengobatan.

b. Tahap lanjutan

Pengobatan fase lanjutan merupakan episode yang sangat krusial untuk melenyapkan kuman *mycobacterium tuberculosis* yang masih ada, khususnya kuman persister, yang masih ada dalam tubuh. Tahap ini bertujuan untuk memastikan pasien sembuh sepenuhnya dan mencegah terjadinya kekambuhan. Lama pengobatan pada tahap lanjutan ini adalah 4 bulan (Kemenkes RI, 2014).

1) Hasil pengobatan

Tabel 2.1 Hasil Pengobatan Pasien TB

Hasil pengobatan	Definisi
Sembuh	Pasien Tuberkulosis Paru dengan dinyatakan bakteriologis positif pada awal pengobatan, tetapi menunjukkan hasil pemeriksaan BTA sputum negatif atau biakan negatif pada akhir pengobatan, serta memiliki hasil pemeriksaan negatif pada salah satu pemeriksaan sebelumnya.
Pengobatan Lengkap	Pasien Tuberkulosis (TB) yang sudah menyelesaikan terapynya secara utuh

	dan tidak mempunyai bukti gagal pengobatan, namun tidak ada hasil hasil BTA sputum atau biakan negatif pada akhir pengobatan serta pada salah satu pemeriksaan sebelumnya, baik karena pemeriksaan tidak dilakukan atau karena hasilnya tidak tersedia.
Gagal	Pasien TB dengan hasil BTA Sputum atau biakan kuman positif pada bulan kelima atau akhir pengobatan.
Meninggal	Pasien Tuberkulosis (TB) yang meninggal dunia karena sebab apapun pada masa selama menjalani pengobatan.
Putus berobat (<i>loss to follow-up</i>)	Pasien Tuberkulosis (TB) yang tidak memulai mengikuti program terapi setelah dinyatakan menderita TB, atau yang mengakhiri pengobatannya selama 2 bulan berturut-turut atau lebih.
Tidak Dievaluasi	Pasien yang tidak mempunyai hasil pengobatan pada akhir pelaporan kohort pengobatan, termasuk pasien yang sudah pindah ke fasilitas kesehatan lain dan hasil pengobatannya tidak diketahui oleh fasilitas yang merujuk pada batas akhir pelaporan kohort pengobatan
Keberhasilan pengobatan	Jumlah kasus yang berhasil sembuh dan menyelesaikan pengobatan secara komplit.

Sumber:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020

H. Pencegahan Penyakit TB Paru

Menurut Kemenkes RI (2020) yang perlu dilakukan dalam pencegahan penyakit TB Paru yaitu :

1. Mengidentifikasi seluruh penderita TB dan segera memberikan pengobatan yang sesuai.
2. Mengonsumsi Obat Anti Tuberkulosis (OAT) secara teratur hingga terapi selesai atau hingga pasien dinyatakan sembuh.
3. Menggunakan masker atau menutup mulut dengan tisu, sapu tangan, atau kain dalam lengan baju saat batuk untuk mencegah penyebaran bakteri.
4. Membuang dahak di tempat yang tertutup atau fasilitas pembuangan khusus setelah batuk.
5. Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai cara penularan, langkah-langkah pencegahan, serta pentingnya deteksi dini untuk penanganan yang lebih efektif
6. Vaksinasi *Bacillus Calmette-Guerin (BCG)*

Vaksin BCG berperan penting dalam mencegah bentuk TB yang berat, meskipun efektivitas perlingkungannya dapat bervariasi. Vaksin ini membantu melindungi anak-anak dari risiko TB diseminata serta TB *ekstrapulmoner* yang parah, seperti TB meningitis dan TB miliar. Pemberian vaksin dilakukan secara intradermal pada bayi yang belum terinfeksi, idealnya segera setelah lahir hingga usia satu bulan(Kemenkes, 2020).

I. Komplikasi

Tuberkulosis dapat mengancam jiwa jika tidak adanya pengobatan. Penyakit tuberkulosis aktif umumnya menyerang paru-paru, Namun, kuman Tuberkulosis tidak hanya terbatas menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyebar melalui aliran darah ke organ lain dalam tubuh Berikut adalah komplikasi tuberkulosis paru (Wahdi & Puspitosari, 2021):

1. Nyeri tulang belakang: tuberkulosis dapat menyebabkan nyeri punggung dan kekakuan.
2. Kerusakan sendi: Tuberkulosis arthritis sering kali mengenai sendi panggul dan sendi lutut.
3. Infeksi meningitis dapat mengakibatkan sakit kepala yang berlangsung lama, yang bisa datang dan pergi selama beberapa minggu.
4. Gangguan hati atau ginjal dapat terjadi karena kedua organ ini berperan penting dalam menyaring zat sisa dari darah. Infeksi tuberkulosis yang menyebar dapat memengaruhi fungsi hati dan ginjal, sehingga mengganggu proses detoksifikasi dan keseimbangan tubuh.
5. Masalah jantung: walaupun jarang terjadi, tuberkulosis dapat menyerang jaringan di sekitar jantung, seperti perikardium, dan mengakibatkan penimbunan cairan (efusi perikardial) yang bisa menghambat fungsi jantung dalam memompa darah secara optimal (Wahdi & Puspitosari, 2021).



BAB 3

Konsep Keluarga

A. Pengertian Keluarga

Menurut Duvall dan Logan (1986) dalam Setawan Ridwan (2016), keluarga adalah kumpulan orang yang terjalin oleh pernikahan, kelahiran, atau adopsi, dengan maksud untuk menciptakan, melestarikan tradisi, serta meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari setiap anggota keluarga (Ridwan Setiawan, 2016). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, keluarga adalah unit terkecil komunitas yang meliputi dari ayah, ibu dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya ("Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera," 1992).

B. Ciri-Ciri Keluarga

Ciri keluarga antara lain:

1. Memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat, yang didasari oleh semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.
2. Merupakan satu kesatuan yang utuh, yang dijiwai oleh nilai-nilai tradisi ketimuran yang kuat serta memiliki rasa komitmen yang besar.

Pada Umumnya, keluarga dipimpin oleh suami sebagai kepala keluarga yang memiliki tugas dominan dalam pengambilan keputusan, walaupun keputusan yang diambil tersebut tetap dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat secara bersama anggota keluarga lainnya. (Ali Zaidin H, 2009)

C. Tipe Keluarga

Keluarga termasuk dalam area fokus pelayanan keperawatan, sehingga perawat perlu memahami berbagai jenis keluarga agar dapat memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dan efektif.

1. Tradisional

a. *The Nuclear Family* (Keluarga Inti)

Keluarga inti/nuclear family merujuk pada struktur keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak yang hidup Bersama dalam satu atap. Dalam Jenis keluarga ini, orang tua berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas untuk memberikan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan kepada anak-anaknya. Anak-anak

dalam keluarga inti biasanya merupakan keturunan langsung.

b. *The Dyad Family*

Keluarga diad atau dyad family merujuk pada unit keluarga yang terdiri dari dua individu, biasanya pasangan suami istri atau pasangan yang belum menikah yang hidup bersama. Dalam struktur keluarga ini, hanya ada dua orang yang berbagi kehidupan bersama dan menjalankan tanggung jawab serta peran masing-masing, tanpa kehadiran anak-anak.

c. Keluarga Usila

Keluarga usila merujuk pada struktur keluarga yang terdiri dari pasangan yang sudah lanjut usia, yaitu kedua orang tua yang telah memasuki usia pensiun atau usia lanjut, tanpa kehadiran anak-anak yang tinggal bersama mereka. Dalam keluarga jenis ini, pasangan lansia hidup bersama atau secara mandiri, dan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan mereka di masa tua.

d. *The Childless Family*/Keluarga Tanpa Anak

Keluarga tanpa anak atau *childless family* merupakan jenis keluarga yang meliputi pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak, baik karena keputusan pribadi, faktor kesehatan, atau ketidakmampuan untuk memiliki anak. Dalam struktur keluarga ini, hubungan antara pasangan lebih fokus pada kehidupan berdua tanpa kehadiran anak-anak di dalam rumah tangga.

e. *The Extended Family*

Keluarga besar atau *extended family* adalah jenis keluarga yang melibatkan lebih dari sekadar pasangan suami istri dan anak-anak. Dalam struktur keluarga ini, terdapat tambahan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama atau dekat, seperti orang tua, mertua, kakek-nenek, paman, bibi, serta sepupu atau saudara lainnya. Keluarga besar dapat terdiri dari beberapa generasi yang saling berinteraksi dan berbagi tanggung jawab.

f. *The Single Parent Family*

Keluarga orang tua tunggal atau *single parent family* merupakan tipe keluarga yang terdiri dari satu orang tua (baik ibu atau ayah) yang membesarkan anak-anak tanpa kehadiran pasangan. Biasanya, keluarga ini terbentuk karena perceraian, perpisahan, atau kematian salah satu pasangan, meskipun ada juga orang tua tunggal yang memilih untuk memiliki anak tanpa menikah.

g. *Commuter Family*

Keluarga komuter adalah jenis keluarga di mana salah satu atau kedua orang tua bekerja di lokasi yang jauh dari tempat tinggal mereka, sehingga mereka terpaksa menjalani hubungan jarak jauh (*long distance relationship*) dengan anggota keluarga lainnya. Biasanya, orang tua akan bepergian secara teratur antara tempat kerja dan rumah, dan mereka sering menghabiskan waktu di tempat kerja selama beberapa hari atau minggu.

sebelum kembali ke rumah untuk waktu yang terbatas.

h. *Multigenerational Family*

Keluarga multigenerasi adalah struktur keluarga yang melibatkan lebih dari dua generasi yang tinggal bersama atau dalam hubungan yang sangat dekat. Dalam keluarga ini, anggota keluarga dari beberapa generasi—seperti kakek-nenek, orang tua, anak-anak, dan bahkan cucu—hidup tinggal dalam satu rumah atau saling mendukung pada kegiatan sehari-hari. Keluarga multigenerasi sering kali terjalin dengan erat karena nilai-nilai keluarga yang kuat, serta saling berbagi tanggung jawab dan dukungan emosional.

i. *Kin-Network Family*

Keluarga jaringan kekerabatan atau *kin-network family* adalah jenis keluarga yang terbentuk oleh hubungan antar anggota keluarga yang lebih luas, di luar struktur inti atau multigenerasi. Dalam keluarga jenis ini, tidak semua anggota keluarga tinggal bersama di satu rumah, tetapi mereka tetap memiliki ikatan yang kuat dan saling mendukung satu sama lain. Jaringan kekerabatan ini bisa mencakup kerabat dari berbagai cabang keluarga, seperti paman, bibi, sepupu, dan anggota keluarga lainnya yang saling berhubungan secara emosional dan sosial.

j. *Blended Family*

Keluarga campuran atau *blended family* merupakan jenis keluarga yang terbentuk ketika dua keluarga yang terpisah karena perceraian atau perpisahan bergabung dan membentuk satu keluarga baru. Dalam keluarga jenis ini, salah satu atau kedua pasangan memiliki anak dari hubungan sebelumnya, dan anak-anak tersebut menjadi bagian dari struktur keluarga yang baru, yang menciptakan kombinasi antara anak-anak biologis dan anak-anak tiri.

k. *Single Adult Living Alone/Single Adult Family*

Keluarga dewasa tunggal yang tinggal sendiri adalah tipe keluarga di mana seorang individu yang tidak menikah atau berstatus janda/duda tinggal sendiri, tanpa ada anggota keluarga lain yang tinggal bersamanya. Individu ini mungkin sudah berusia dewasa, dan memilih untuk hidup sendiri karena berbagai alasan, seperti pekerjaan, studi, atau pilihan pribadi. Keluarga ini sering kali mencerminkan kehidupan mandiri, di mana seseorang memiliki kontrol penuh atas kegiatan sehari-hari dan tanggung jawab rumah tangga.

2. Non-Tradisional

a. *The Unmarried Teenage Mother*

Merupakan seorang wanita muda, umumnya berusia antara 13 hingga 19 tahun, yang melahirkan dan merawat anak tanpa berada dalam ikatan

pernikahan. Situasi ini sering kali menimbulkan tantangan besar, baik bagi ibu muda tersebut maupun bagi anak yang dilahirkannya, serta bagi keluarga yang memberikan dukungan.

b. *The Stepparent Family*

Keluarga orang tua tiri adalah jenis keluarga yang terbentuk ketika salah satu pasangan menikah dengan seseorang yang sudah memiliki anak dari pernikahan atau hubungan sebelumnya. Dalam keluarga ini, salah satu atau kedua pasangan bertindak sebagai orang tua tiri bagi anak-anak pasangan mereka, yang sering kali menambah dinamika hubungan yang lebih kompleks dalam keluarga tersebut. Hubungan orang tua tiri dengan anak tiri ini bisa bervariasi, tergantung pada usia anak-anak, hubungan yang sudah ada sebelumnya, serta bagaimana orang tua tiri beradaptasi dengan peran baru mereka.

c. *Commune Family*

Keluarga *komune* adalah sebuah tipe keluarga yang terdiri dari sekelompok orang yang memilih untuk hidup bersama dengan tujuan untuk berbagi sumber daya, tanggung jawab, dan kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga komune, anggota keluarga seringkali tidak terikat oleh hubungan darah atau ikatan pernikahan tradisional, melainkan lebih kepada prinsip berbagi nilai-nilai bersama, seperti kesetaraan, solidaritas, dan kerjasama. Biasanya, model keluarga ini lebih menekankan

pada kehidupan kolektif dan kolegalitas, daripada pembentukan keluarga inti tradisional.

d. *The Nonmarital Heterosexual Cohabiting Family*

Keluarga heteroseksual yang tinggal satu rumah tanpa menikah merujuk pada pasangan lak-laki dan perempuan yang hidup bersama sebagai pasangan intim tanpa ikatan perkawinan resmi. Mereka memilih untuk hidup bersama, berbagi rumah tangga, dan menjalani kehidupan bersama, meskipun tidak terikat secara hukum melalui pernikahan. Meskipun pasangan ini mungkin memiliki ikatan emosional dan kehidupan bersama yang mirip dengan pasangan menikah, mereka tetap memilih untuk tidak menikah karena berbagai alasan, seperti keyakinan pribadi, status hukum, atau alasan ekonomi.

e. *Gay and Lesbian Families*

Keluarga *gay* dan lesbian merujuk pada pasangan sesama jenis yang membentuk keluarga, baik dengan atau tanpa anak. Pasangan gay (pria dengan pria) dan lesbian (wanita dengan wanita) dapat membentuk hubungan jangka panjang dan sering kali tinggal bersama sebagai pasangan intim, mirip dengan pasangan heteroseksual yang menikah. Dalam beberapa kasus, pasangan gay dan lesbian memilih untuk memiliki anak, baik melalui adopsi, inseminasi buatan, atau dengan membesarkan anak-anak dari hubungan sebelumnya. Dinamika keluarga ini dapat bervariasi, namun sering kali

menghadapi tantangan terkait stigma sosial, diskriminasi, dan peraturan hukum yang tidak selalu mengakui atau melindungi hak-hak mereka.

f. *Cohabiting Couple*

Pasangan yang tinggal bersama (*cohabiting couple*) merujuk pada pasangan yang memilih untuk hidup bersama tanpa ikatan pernikahan resmi. Meskipun pasangan ini tidak terikat oleh hukum melalui pernikahan, mereka berbagi kehidupan sehari-hari, rumah tangga, dan komitmen emosional seperti pasangan menikah. Pasangan yang tinggal bersama ini dapat terdiri dari pasangan heteroseksual atau sesama jenis, dan mereka mungkin memilih untuk hidup bersama karena alasan pribadi, praktis, atau ekonomi, tanpa kebutuhan untuk melangsungkan pernikahan.

g. *Group-Marriage Family*

Keluarga pernikahan kelompok (*group-marriage family*) merujuk pada jenis keluarga yang melibatkan lebih dari dua orang dalam hubungan pernikahan atau kemitraan, di mana beberapa individu (biasanya lebih dari dua orang) terlibat dalam pernikahan atau hubungan rumah tangga bersama. Dalam struktur keluarga ini, semua anggota keluarga memiliki hubungan emosional dan romantis satu sama lain, dan mereka mungkin berbagi tanggung jawab rumah tangga, pengasuhan anak, dan kehidupan bersama. Meskipun jarang, jenis keluarga ini dapat ditemukan

dalam beberapa komunitas atau budaya yang mendukung hubungan poliamori atau kemitraan yang lebih terbuka.

h. *Group Network Family*

Keluarga jaringan kelompok (*group network family*) adalah tipe keluarga yang terdiri dari sekelompok individu yang tidak terikat oleh hubungan darah atau ikatan pernikahan, tetapi mereka memiliki ikatan sosial dan emosional yang kuat. Anggota keluarga ini mungkin tinggal di lokasi yang terpisah, tetapi mereka tetap berinteraksi secara rutin dan saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan. Kelompok ini sering kali berfungsi seperti keluarga inti dalam hal dukungan sosial, pengasuhan, dan tanggung jawab bersama.

i. *Foster Family*

Keluarga asuh (*foster family*) adalah jenis keluarga di mana pasangan atau individu menerima anak-anak yang tidak dapat tinggal dengan orang tua biologis mereka, baik untuk sementara waktu atau dalam jangka panjang, dengan tujuan memberikan perawatan dan pengasuhan yang aman dan penuh kasih. Anak-anak yang ditempatkan dalam keluarga asuh sering kali berasal dari situasi yang tidak stabil atau berbahaya, seperti masalah keluarga, pengabaian, kekerasan, atau ketidakmampuan orang tua untuk merawat mereka.

j. *Homeless Family*.

Keluarga tanpa tempat tinggal (*homeless family*) adalah keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal tetap atau permanen. Keluarga-keluarga ini seringkali tinggal di tempat penampungan darurat, tempat umum, atau bahkan di kendaraan. Mereka menghadapi tantangan besar dalam memperoleh kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang aman, makanan, air bersih, dan akses ke layanan kesehatan. Keluarga tanpa tempat tinggal dapat terbentuk karena berbagai faktor, termasuk kehilangan pekerjaan, masalah keuangan, bencana alam, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah kesehatan mental.

k. *Gang*

Istilah *gang family* atau keluarga gang merujuk pada kelompok individu yang memiliki ikatan kuat satu sama lain, namun hubungan tersebut tidak didasarkan pada hubungan darah atau pernikahan, melainkan ikatan yang terbentuk melalui afiliasi dengan kelompok atau geng tertentu. Keluarga gang biasanya terbentuk dari anggota-anggota geng yang berbagi nilai, tujuan, dan pengalaman hidup yang sama. Mereka sering kali memiliki hubungan yang sangat erat, meskipun mereka terikat oleh hukum dan norma yang berbeda dibandingkan dengan keluarga tradisional (Friedman, 1998).

D. Struktur Keluarga

Struktur keluarga erat kaitannya dengan fungsi keluarga dan terus berinteraksi. Menurut Friedman (1988), struktur keluarga meliputi:

1. Pola dan Proses Komunikasi
Komunikasi dapat efektif atau tidak, tergantung pada faktor seperti pengirim, media, pesan, lingkungan, dan penerima.
2. Struktur Peran
Peran adalah tingkah laku yang diinginkan sesuai status sosial seseorang dalam keluarga.
3. Struktur Kekuatan
Kekuatan adalah potensi seseorang mengontrol atau mempengaruhi orang lain secara positif.
4. Nilai-nilai Keluarga
Sistem kepercayaan dan norma yang mengarahkan perilaku anggota keluarga.

Bentuk ikatan darah dalam keluarga:

1. *Patrilineal*:
Patrilineal adalah sistem keturunan atau garis keturunan yang mengikuti jalur pihak ayah. Dalam sistem ini, anggota keluarga (terutama anak-anak) dianggap sebagai bagian dari garis keturunan atau keluarga dari pihak ayah. Dengan kata lain, nama keluarga, harta warisan, dan status sosial sering kali diwariskan melalui pihak ayah dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal.

2. *Matrilineal:*

Matrilineal adalah sistem keturunan di mana garis keturunan atau warisan diturunkan melalui pihak ibu. Dalam sistem matrilineal, nama keluarga, warisan, dan identitas keluarga biasanya diteruskan melalui jalur ibu, bukan ayah. Artinya, anak-anak dianggap sebagai bagian dari keluarga ibu mereka, dan hak-hak sosial serta properti lebih sering diwariskan melalui ibu

3. *Matrilokal:*

Matrilokal adalah sistem tempat tinggal di mana pasangan yang baru menikah menetap bersama atau dekat dengan keluarga pihak istri, khususnya ibu dari istri. Dalam tradisi ini, rumah atau lingkungan keluarga istri menjadi tempat tinggal utama pasangan setelah menikah.

4. *Patrilokal:*

Patrilokal adalah sistem tempat tinggal di mana pasangan yang baru menikah tinggal dengan atau dekat dengan keluarga pihak suami, khususnya dengan keluarga ayah. Dalam sistem ini, setelah pernikahan, pasangan akan menetap di rumah atau wilayah keluarga ayah, bukan di keluarga ibu. Ini adalah kebalikan dari sistem matrilokal, di mana pasangan tinggal dengan keluarga pihak ibu.

5. Keluarga Kawinan:

Keluarga kawinan, juga dikenal sebagai keluarga inti merupakan unit keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak yang belum menikah atau tinggal serumah. Dalam keluarga kawinan, hubungan

utama adalah antara suami dan istri, yang diikat oleh pernikahan, dan anak-anak mereka yang tinggal bersama mereka di rumah yang sama.

E. Fungsi Keluarga

Menurut Siswanto (2006), fungsi keluarga meliputi:

1. Reproduksi:
Mempertahankan keturunan dan mengembangkan fungsi seksual sehat.
2. Sosialisasi:
Membentuk identitas diri anak sesuai budaya.
3. Pertumbuhan Individu:
Membantu anak menjadi mandiri dan matang.
4. Pendidikan:
Menambah dan mengasah ilmu pengetahuan anak.
5. Religius:
Membina nilai keagamaan dalam keluarga.
6. Ekonomi:
Memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti pangan, sandang, papan, serta mengelola sumber daya keuangan demi kesejahteraan seluruh anggota keluarga.
7. Rekreasi:
Tempat kegiatan santai untuk mengurangi ketegangan.
8. Perawatan Kesehatan:
Melakukan upaya pencegahan dan pengobatan dalam keluarga

F. Tugas Keluarga di Bidang Kesehatan

Berdasarkan Friedman (1998):

1. Mengenali masalah kesehatan keluarga.
2. Memutuskan tindakan kesehatan yang tepat.
3. Merawat anggota keluarga yang sakit.
4. Memodifikasi lingkungan untuk kesehatan.
5. Memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia (Friedman, 1998).

G. Sistem Keluarga

Keluarga dianggap sebagai sistem sosial terbuka yang ada dan berelasi dengan sistem yang lebih besar (suprasistem) dari komunitas (misal: politik, agama, sekolah dan pemberian pelayanan kesehatan). Sistem keluarga terdiri dari bagian yang saling berhubungan (anggota keluarga) yang membentuk berbagai macam cara interaksi (subsistem). Seperti pada seluruh sistem, sistem keluarga mempunyai dua tujuan baik impisit maupun eksplisit, yang berbeda berdasarkan fase pada siklus hidup keluarga, nilai keluarga dan kepedulian individual anggota keluarga.

Komponen sistem keluarga:

1. Input, anggota keluarga, struktur, fungsi, aturan, lingkungan, budaya, agama
2. Proses, proses pelaksanaan fungsi keluarga
3. *Output*, hasil berupa perilaku: sosial, agama, kesehatan
4. *Feedback*, pengontrol perilaku keluarga

Karakteristik keluarga sebagai sistem:

1. Sistem terbuka, sistem yang punya kesempatan dan mau menerima / memperhatikan lingkungan sekitar.
2. Sistem tertutup, kurang punya kesempatan, kurang mau menerima /memberi perhatian pada lingkungan sekitar (Susilo, 2010)

H. Peran Keluarga

Peran keluarga mendeskripsikan sekumpulan tindakan interpersonal, sifat, aktivitas yang berhubungan dengan individu pada status dan kondisi tertentu. Peran individu dalam keluarga dilandasi oleh keinginan dan pola tingkah laku dari keluarga, kelompok dan masyarakat.

Berbagai peranan yang ada pada keluarga adalah antara lain:

1. Peran Ayah:

Ayah sebagai kepala keluarga, suami dari istri ayah dari anak-anak, mempunyai peran sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.

2. Peran Ibu:

Sebagai istri dan ibu dari anak-anak, ibu memiliki peran untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu

juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya.

3. Peran Anak:

Anak-anak menjalankan peran psikososial sesuai dengan tahap perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual (Friedman, 1998).

I. Tugas Perkembangan Sesuai Dengan Tahap Perkembangan (Duval) (*Sociological Perspective*)

1. Keluarga baru menikah

Menjalin kedekatan emosional dan fisik, mempererat hubungan dengan keluarga besar, menjaga interaksi positif dengan teman serta lingkungan sosial, serta merencanakan waktu dan kesiapan untuk memiliki anak.

2. Keluarga dengan anak baru lahir

a. Persiapan menjadi orang tua

Menyiapkan diri secara fisik, mental, dan emosional untuk menjalani peran sebagai ayah dan ibu.

b. Adaptasi keluarga baru, interaksi keluarga, hubungan seksual

Menyesuaikan diri dalam kehidupan rumah tangga baru, membangun pola komunikasi dan hubungan antar anggota keluarga, serta mengembangkan keintiman sebagai pasangan suami istri.

3. Keluarga dengan anak usia pra sekolah

a. Memenuhi keperluan anggota keluarga.

b. Menolong anak untuk bersosialisasi

c. Menjaga hubungan yang sehat keluarga intern dan luar

- d. Distribusi tanggung jawab
- e. Aktivitas untuk merangsang perkembangan anak
- 4. Keluarga dg anak usia sekolah
 - a. Membantu anak bersosialisasi dengan lingkungan luar.
 - b. melestarikan keintiman pasangan.
 - c. memenuhi tuntutan yang bertambah.
- 5. Keluarga dengan anak remaja.
 - a. Memberikan kemandirian yang seimbang dan bertanggung jawab.
 - b. Melestarikan relasi yang intim dengan keluarga.
 - c. Komunikasi terbuka: hindari perdebatan dan permusuhan.
 - d. Menyiapkan perubahan sistem peran.
- 6. Keluarga mulai melepas anak sebagai dewasa
 - a. Perluas jaringan keluarga dari keluarga inti ke extended
 - b. Pertahankan keintiman pasangan
 - c. Membantu anak untuk mandiri sebagai keluarga baru
 - d. Penataan kembali peran orang tua
- 7. Keluarga usia pertengahan
 - a. Melindungi kesehatan individu dan pasangan usia pertengahan
 - b. Hubungan serasi antara anak- anak dengan sebaya
 - c. Meningkatkan kedekatan pasangan
- 8. Keluarga usia tua
 - a. Pertahankan kondisi saling menyenangkan
 - b. Adaptasi perubahan: kehilangan pasangan, kekuatan fisik dan pendapatan
 - c. Pertahankan keintiman pasangan

- d. Melakukan life review masa lalu
- 9. Keluarga usia tua
 - a. Pertahankan kondisi saling menyenangkan
 - b. adaptasi perubahan: kehilangan pasangan, kekuatan fisik, pendapatan.
 - c. pertahankan keintiman pasangan
 - d. melakukan life review masa lalu(Maria H. Bakri, 2018).

BAB 4

Peran Keluarga Dalam Perawatan Penderita TB Paru

A. Karakteristik

Tabel 4.1 Distribusi Partisipan berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	%
1	21-40 tahun	1	20
2	31-40 tahun	0	0
3	41-50 tahun	0	0
4	51-60 tahun	3	60
5	> 60 tahun	1	20
Jumlah		5	100

Sumber: Data primer 2021

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa sebagian besar partisipan umur 51-60 tahun sebanyak 3 partisipan (60%).

Tabel 4.2 Distribusi Partisipan berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	2	40
2	Perempuan	3	60
Jumlah		5	100

Sumber: Data primer 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa sebagian besar partisipan berjenis kelamin perempuan sebanyak 3 partisipan (60%).

Tabel 4.3 Distribusi Partisipan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	2	40
2	SMP	0	
3	SMA	3	60
Jumlah		5	100

Sumber: Data primer 2021

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa sebagian besar partisipan pendidikan SMA sebanyak 3 partisipan (60%).

Tabel 4.4 Distribusi Partisipan berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Petani	1	20
2	Pensiunan	1	20
3	Ibu Rumah Tangga	3	60
Jumlah		5	100

Sumber: Data primer 2021

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa sebagian besar partisipan ibu rumah tangga sebanyak 3 partisipan (60%).

B. Peran Keluarga dalam Perawatan Penderita TB Paru

Keluarga adalah dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan ikatan dan kedekatan emosional, baik memiliki maupun tidak memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Keanggotaan dalam keluarga tidak dibatasi secara kaku, melainkan berdasarkan kedekatan dan komitmen antar individu (Siti Riskika dkk, 2021).

Tipe keluarga yang berperan penting dalam perawatan penderita TB Paru adalah keluarga inti (*nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, baik anak kandung hasil perkawinan maupun anak adopsi (Siti Riskika dkk, 2021). Keluarga inti merupakan orang-orang terdekat yang hidup bersama penderita dan memiliki peran besar dalam proses perawatan dan pemulihan. Namun, pada banyak kasus ditemukan bahwa penderita TB Paru seringkali harus berjuang sendiri, padahal peran keluarga sangat dibutuhkan. Hal ini penting karena keluarga adalah pihak yang terdampak langsung secara fisik, emosional, dan sosial dari kondisi penderita TB Paru. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jufrisal (2016) menunjukkan bahwa peran keluarga sangat signifikan dalam keberhasilan pengobatan penyakit TBC Paru (Jufrisal et al., 2016).

Peran keluarga dapat dipahami sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi atau kedudukannya dalam keluarga. Contohnya, ayah berperan sebagai kepala rumah tangga, sementara ibu biasanya bertanggung jawab dalam merawat anak. Struktur peran

dalam keluarga dapat bersifat formal maupun informal. Peran formal meliputi tugas-tugas yang jelas seperti: pencari nafkah, ibu rumah tangga, merawat anak, mengelola keuangan, kegiatan rekreasi keluarga, peran terapeutik (seperti merawat anggota keluarga yang sakit), serta peran reproduksi/seksual. Peran informal bersifat implisit dan tidak selalu tampak, namun sangat penting, misalnya membina keharmonisan, memberi motivasi, menunjukkan empati, serta menjadi inisiator dalam pengambilan keputusan keluarga (Lukman, 2024).

Ketika ada anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan, maka keluarga berkewajiban memberikan perhatian dan perawatan awal. Jika masalah kesehatan masih tergolong ringan, pertolongan pertama bisa dilakukan di rumah. Namun jika kondisi tidak membaik atau dirasa berat, maka keluarga perlu membawa anggota yang sakit ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat (Lukman, 2024).

Selama ini, peran keluarga dalam merawat penderita TB Paru masih bersifat parsial atau belum dilakukan secara menyeluruh. Keluarga cenderung hanya memberikan bantuan ketika penderita secara langsung membutuhkan pertolongan. Dalam banyak kasus, bantuan hanya datang dari pasangan penderita, sementara anggota keluarga lainnya menunjukkan sikap yang pasif dan kurang terlibat dalam proses perawatan. Padahal, ketika ada anggota keluarga yang sakit, peran aktif dari seluruh anggota

keluarga sangat dibutuhkan untuk mendukung proses penyembuhan secara optimal. Keterlibatan kolektif keluarga tidak hanya mempercepat pemulihan penderita, tetapi juga dapat mencegah penularan penyakit dan memperkuat dukungan psikososial di lingkungan rumah.

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan bahwa keluarga penderita TB Paru memiliki Peran antara lain:

1. Peran Keluarga dalam Mengatasi Keluhan Batuk pada Penderita TB Paru

Keluhan yang paling sering dialami oleh penderita TBC Paru adalah batuk. Batuk merupakan respons refleksi alami tubuh yang berfungsi untuk membersihkan saluran napas dari iritasi, lendir, debu, atau benda asing lainnya. Mekanisme ini sebenarnya adalah bentuk perlindungan tubuh terhadap gangguan pada sistem pernapasan.

Pada penderita TBC Paru, batuk biasanya berlangsung selama dua minggu atau lebih. Pada tahap awal, penderita umumnya mengalami batuk kering, yang kemudian berkembang menjadi batuk berdahak. Dahak yang dikeluarkan bisa berwarna putih, kekuningan, dan dalam beberapa kasus bahkan bercampur darah (hemoptisis), tergantung pada tingkat keparahan infeksi dan kondisi paru-paru penderita.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa salah satu bentuk peran keluarga terhadap penderita TB Paru yang mengalami batuk adalah dengan memberikan air hangat

kepada penderita. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meredakan batuk dan membantu penderita merasa lebih nyaman.

Di bawah ini merupakan kutipan pernyataan informan yang menggambarkan peran tersebut:

"Saya kasih air hangat supaya batuk kurang..." (P2)

"...Saya kasih air panas supaya batuk kurang..." (P3)

Pemberian air hangat kepada penderita TB Paru sangat membantu dalam mengencerkan dahak, sehingga saluran pernapasan menjadi lebih lancar. Dahak yang lebih encer lebih mudah dikeluarkan, dan ini dapat mengurangi intensitas serta ketidaknyamanan akibat batuk.

Temuan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi Putra Sudarma Made I dan Rahayu Novita Mahendra Kadek (2017), yang menyatakan bahwa pemberian air minum hangat memberikan efek hidrostatik dan hidrodinamik sehingga membantu menjaga saluran napas tetap paten atau terbuka (Adiputra & Rahayu, 2017)

Hasil yang dilakukan oleh Hardina Sri & Wulandari (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh konsumsi air hangat terhadap frekuensi napas pada kelompok intervensi. Dalam penelitian tersebut, kelompok yang diberikan intervensi berupa konsumsi air hangat mengalami penurunan frekuensi napas yang signifikan

dibandingkan dengan kelompok kontrol (Sri Hardina, Septiyanti, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian air hangat tidak hanya membantu mengencerkkan dahak, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan kondisi pernapasan penderita, termasuk penderita TB Paru.

2. Peran Keluarga dalam upaya pencegahan penularan penyakit TB Paru

Penyakit Tuberkulosis Paru (TB Paru) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Penularan terjadi melalui percikan ludah (droplet) yang keluar saat penderita batuk atau bersin. Ketika seorang penderita TB Paru batuk atau bersin satu kali, dapat menyebarkan sekitar 3.000 kuman TB ke udara. Penderita TB Paru aktif yang mengalami batuk berulang bahkan dapat menyebarkan jutaan kuman ke lingkungan sekitarnya (Aja et al., 2022).

Transmisi atau penularan kuman TB dapat terjadi baik di dalam maupun di luar ruangan. Kuman *Mycobacterium tuberculosis* diketahui dapat bertahan lama di ruangan yang gelap, lembap, dan tidak terkena sinar matahari, sehingga meningkatkan risiko penularan dalam kondisi rumah yang kurang ventilasi (Hanida, 2018).

Penderita TB Paru dengan BTA (Basil Tahan Asam) positif yang tinggal di rumah dan tidak menerapkan protokol kesehatan secara optimal berpotensi menularkan

penyakit kepada 10–15 orang anggota keluarga dalam kurun waktu satu tahun (Kristini & Hamidah, 2020).

Oleh karena itu, upaya pencegahan penularan sangat penting dilakukan, dimulai dari lingkungan terdekat yaitu:

a. Penggunaan masker

Berdasarkan wawancara, informan menyatakan bahwa penggunaan masker tetap dilakukan, baik di dalam rumah maupun saat berada di luar rumah:

“...tetap pakai masker...” (P1)

Masker merupakan alat pelindung yang efektif untuk mencegah penularan TB Paru. Masker medis sangat dianjurkan, terutama bagi penderita TB Paru, khususnya saat berinteraksi dengan orang lain. Masker sebaiknya diganti minimal satu kali sehari atau saat masker menjadi basah akibat batuk atau bersin. Masker bekas pakai harus dibuang ke tempat sampah tertutup (Kementerian Kesehatan, 2025)

Hasil ini diperkuat oleh penelitian Lailatul Nur, Rohmah, dan Wicaksana (2015), yang menyatakan bahwa penggunaan masker secara konsisten merupakan langkah efektif dalam memutus rantai penularan TB Paru(Lailatul et al., 2015).

b. Pemisahan alat makan

Informan juga mengungkapkan bahwa mereka memisahkan alat makan penderita dengan anggota keluarga lain:

"...pisahkan alat makan..." (P1, P2, P3, P4)

Pemisahan alat makan dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa kuman TB dapat berpindah melalui droplet yang menempel pada peralatan makan saat penderita batuk atau bersin. Temuan ini selaras dengan penelitian Jaji (2010), yang menyatakan bahwa pemisahan alat makan merupakan salah satu tindakan preventif yang dilakukan keluarga untuk menghindari penularan TB Paru (Jaji, 2010).

c. Tidur secara terpisah dengan penderita TB Paru

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa salah satu upaya pencegahan penularan TB Paru di lingkungan keluarga adalah dengan tidur secara terpisah antara penderita dan anggota keluarga yang sehat. Pernyataan informan terkait hal ini diuraikan sebagai berikut:

"...tidur pisah... saya dan cuci sendiri..." (P1)

"...tidur pisah..." (P2, P3, P4, P5)

Tidur terpisah menjadi salah satu langkah penting dalam meminimalisasi risiko penularan kuman *Mycobacterium tuberculosis* melalui droplet yang dilepaskan saat penderita batuk atau bersin, terutama di malam hari ketika berada dalam satu ruangan tertutup. Kuman TB dapat bertahan di udara selama 1–2 jam dalam ruangan yang tidak memiliki ventilasi cukup baik (Jaji, 2010). Oleh karena itu, menjaga jarak tidur antara penderita dan anggota keluarga yang sehat, serta memastikan ventilasi ruangan baik, merupakan strategi efektif dalam mencegah penularan TB di lingkungan rumah tangga (Jaji, 2010).

d. Buang dahak pada tempat yang tertutup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa salah satu cara untuk mencegah penularan penyakit Tuberkulosis (TB) Paru kepada anggota keluarga adalah dengan membuang dahak pada media yang tertutup, seperti tisu atau plastik. Beberapa pernyataan informan mendukung hal tersebut:

“...buang dahak di tisu dan masukan ke dalam plastik lalu ikat...” (P1)

“...buang dahak di plastik yang dikasih puskesmas...”
(P2)

“...buang di plastik...” (P3)

Dahak yang dikeluarkan oleh penderita TB Paru mengandung kuman penyebab penyakit TB. Oleh karena itu, tindakan membuang dahak pada tempat tertutup merupakan langkah penting dalam mencegah dan memutus rantai penularan penyakit ini. Tempat tertutup yang dapat digunakan antara lain adalah sputum pot, tisu atau kertas sekali pakai, kaleng tertutup yang telah diisi air sabun, atau langsung dibuang ke dalam toilet yang kemudian disiram hingga bersih.

Pernyataan para informan ini sejalan dengan hasil penelitian Jufrizal dan Hermansyah (2016), yang menyebutkan bahwa upaya pemutusan penularan TB Paru salah satunya dilakukan dengan cara membuang dahak pada tempat yang khusus dan tertutup. (Jufrizal, Hermansyah, 2016)

3. Peran Keluarga Memodifikasi lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan, ditemukan bahwa salah satu upaya pencegahan penularan penyakit Tuberkulosis (TB) Paru pada anggota keluarga adalah dengan melakukan modifikasi lingkungan rumah. Modifikasi lingkungan yang dilakukan keluarga, antara lain dengan membuka pintu dan jendela setiap hari. Pernyataan partisipan terkait hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

"...sering buka pintu dan jendela..." (P1)

"...buka jendela setiap hari..." (P2, P3)

“...pintu dan jendela buka tiap hari...” (P4, P5)

Membuka pintu dan jendela secara rutin setiap hari dapat memperlancar sirkulasi udara di dalam rumah serta memungkinkan masuknya sinar matahari ke dalam ruangan. Kondisi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat karena sinar matahari dan sirkulasi udara yang baik dapat membantu membunuh kuman penyebab TB Paru.

Penelitian yang dilakukan oleh Anis (2006) dalam Nuraini F. Anggi (2015) menyatakan bahwa kebiasaan membuka jendela setiap hari merupakan salah satu upaya efektif untuk mencegah penyebaran kuman di udara, termasuk kuman penyebab tuberkulosis. Jendela yang terbuka pada siang hari memungkinkan terjadinya pertukaran udara yang baik dan paparan sinar matahari secara langsung, keduanya berperan dalam menekan keberadaan kuman di lingkungan. Sebaliknya, apabila jendela tidak dibuka secara rutin, terutama pada siang hari, maka ruangan menjadi lembap, sirkulasi udara buruk, dan tidak mendapat paparan sinar matahari, sehingga menciptakan lingkungan yang ideal bagi kuman TB untuk bertahan hidup dan berkembang (Nuraini, 2015).

4. Peran keluarga menemani pada saat kontrol rutin

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mendukung proses pengobatan penderita TB Paru.

Peran tersebut antara lain berupa menemani pasien saat kontrol rutin ke Puskesmas, mengambil obat, serta mengingatkan pasien untuk minum obat secara teratur. Sebagai orang terdekat, keluarga menjadi pendamping utama yang dapat membantu memastikan kepatuhan pasien terhadap jadwal kontrol dan pengobatan.

Pernyataan informan yang mendukung hal ini antara lain:

"...saya yang temani..." (P2)

"...saya yang temani, kadang ipar..." (P3)

"...saya selama ini yang sama-sama ke puskesmas untuk kontrol..." (P4)

Kontrol rutin bagi penderita TB Paru merupakan bagian integral dari proses penyembuhan, karena melalui kontrol tersebut kondisi kesehatan pasien dapat dipantau dan kemajuan terapi dapat dievaluasi. Kehadiran anggota keluarga dalam proses ini memberikan dukungan emosional dan sosial yang sangat berarti bagi penderita. Dukungan tersebut tidak hanya membuat pasien merasa diperhatikan, tetapi juga meningkatkan motivasi dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan.

Aspek ini menjadi semakin penting mengingat masih banyak penderita TB Paru yang merasa malu atas penyakit yang mereka derita. Perasaan malu ini seringkali berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap terapi. Oleh karena itu, keterlibatan aktif keluarga dalam

mendampingi penderita sangat membantu dalam mengurangi stigma sosial, sekaligus mempercepat proses penyembuhan. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa TB Paru merupakan penyakit kronis yang sulit disembuhkan, sehingga penderita sering mengalami tekanan sosial (Hariadi et al., 2023).

5. Peran keluarga untuk mengingatkan penderita agar rutin minum obat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa keluarga penderita TB Paru berperan aktif dalam mengingatkan penderita untuk rutin mengonsumsi obat. Peran ini terlihat dari beberapa pernyataan partisipan berikut:

"...saya saja yang mengingatkan..." (P1)

"...Bapak dan keluarga yang lain mengingatkan..." (P2)

"...saya sendiri yang kasih ingat agar rutin minum obat..." (P4)

"...saya yang kasih ingat..." (P5)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keluarga berperan penting sebagai pengingat harian bagi penderita agar tidak lupa minum obat. Kepatuhan dalam mengonsumsi obat secara teratur merupakan kunci utama keberhasilan pengobatan TB Paru. Dalam hal ini, keterlibatan keluarga sangat membantu memastikan bahwa obat diminum sesuai dengan jadwal dan dosis yang telah ditentukan.

Dukungan keluarga dalam bentuk pengingat rutin berkontribusi terhadap peningkatan kedisiplinan penderita dalam menjalani terapi. Menurut Jufrizal dan Hermansyah (2016), kehadiran anggota keluarga yang aktif mengingatkan penderita untuk minum obat dapat mencegah terjadinya keterlambatan atau kelalaian dalam pengobatan, sehingga berpengaruh positif terhadap hasil terapi (Jufrizal, Hermansyah, 2016).

Kepatuhan dalam pengobatan TB Paru tidak hanya mempercepat proses penyembuhan, tetapi juga mencegah timbulnya komplikasi seperti resistensi obat, memburuknya gejala penyakit, dan peningkatan risiko penularan kepada orang lain (Kemenkes.RI, 2014).

Selain manfaat fisik, dukungan dari keluarga juga memberikan dampak positif secara emosional bagi penderita. Perhatian dan keterlibatan orang terdekat membuat penderita merasa lebih dihargai, didukung, dan tidak sendirian dalam menghadapi penyakitnya. Rasa kebersamaan ini turut memperkuat motivasi penderita untuk patuh terhadap pengobatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Nazhofah dan Hadi (2022), serta Noviana (2023), yang menyatakan bahwa dukungan keluarga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan penderita TB Paru dalam mengonsumsi obat, yang pada akhirnya berdampak pada kesembuhan pasien. Dukungan tersebut juga

diperkuat oleh penelitian Siallagan et al. (2024) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara dukungan sosial keluarga dan kepatuhan penderita dalam menjalani terapi TB Paru. (Nazhofah & Ella Nurlaella Hadi, 2022; Noviana et al., 2023; Siallagan et al., 2024)

6. Motivasi yang diberikan keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan didapatkan bahwa keluarga memberikan motivasi rutin minum obat, taat pada aturan yang diberikan, jangan merokok, jangan minum minuman keras (alcohol).

Pernyataan partisipan dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

"...kalau mau sembuh harus taat minum obat dan taat pada aturan yang diberikan.." p1

"...Rutin minum obat..jangan merokok jangan miras..." p2

"...Rutin minum obat... jangan merokok..." p3

"...Rutin minum obat... sudah minum obat 4 bulan ada minum obat warna merah sekarang minum obat setiap senin rabu dan jumat"p4

"...Rajin minum obat..." p5

Pernyataan informan pertama menunjukkan bahwa keluarga berperan sebagai pengingat dan motivator bagi pasien. Dengan menyatakan bahwa "kalau mau sembuh harus taat minum obat dan taat pada aturan yang diberikan," keluarga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan sebagai syarat untuk mencapai

kesembuhan. Ini menciptakan kesadaran pada pasien bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi langsung terhadap kesehatan mereka.

Keluarga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan sebagai syarat untuk mencapai kesembuhan. Ini menciptakan kesadaran pada pasien bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi langsung terhadap kesehatan mereka.

Pernyataan informan kedua dan ketiga menekankan pentingnya tidak hanya minum obat secara rutin, tetapi juga menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan mengonsumsi alkohol. Keluarga berusaha untuk membangun kebiasaan sehat yang mendukung proses penyembuhan. Dengan memberikan nasihat ini, keluarga menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan jangka panjang pasien.

Pernyataan informan keempat memberikan contoh konkret tentang jadwal pengobatan, di mana pasien harus minum obat pada hari-hari tertentu. Ini menunjukkan bahwa keluarga berperan dalam membantu pasien mengatur rutinitas mereka. Penjadwalan yang jelas membantu pasien untuk lebih disiplin dan teratur dalam menjalani pengobatan, yang sangat penting dalam pengobatan penyakit seperti TBC. Pernyataan informan kelima, yang menyatakan "rajin minum obat," mencerminkan penguatan positif dari

keluarga. Dengan mendorong pasien untuk rajin minum obat, keluarga memberikan dukungan emosional yang dapat meningkatkan motivasi pasien. Penguatan positif ini dapat membantu pasien merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk mengikuti pengobatan.

Secara keseluruhan, motivasi keluarga yang tercermin dalam pernyataan informan-informan menunjukkan bahwa mereka berperan penting dalam mendukung pasien untuk tetap patuh pada pengobatan. Dukungan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional, yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan mempercepat proses penyembuhan.

Peran keluarga dalam memberikan motivasi sangat penting untuk mendukung kepatuhan penderita TB Paru sehingga penderita dapat minum obat sesuai dengan program terapi yang telah ditentukan sehingga pada pasien TB paru memperoleh kesembuhan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Kristina Handriani dan Sekarwati Novita (2017) mengemukakan bahwa motivasi keluarga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan minum Obat anti tuberkulosis (Kristanti et al., 2017)



BAB 5

Penutup

Keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung proses penyembuhan dan pencegahan penularan penyakit Tuberkulosis Paru (TB Paru). Dukungan ini mencakup aspek fisik, emosional, dan lingkungan yang saling bersinergi untuk membantu penderita menjalani pengobatan dan memutus rantai penularan.

Adapun peran keluarga yang ditemukan antara lain:

1. Peran saat Penderita Batuk.

Keluarga membantu meringankan gejala batuk dengan memberikan air hangat. Ini membantu mengencerkan dahak sehingga saluran napas lebih lega. Tindakan ini terbukti bermanfaat secara klinis dalam mendukung kenyamanan penderita.

2. Peran dalam Upaya Memutus Penularan TB Paru

Keluarga menjalankan berbagai tindakan preventif seperti:

- a. Mewajibkan penggunaan masker baik di dalam maupun di luar rumah.
- b. Memisahkan alat makan penderita.
- c. Tidur terpisah untuk mencegah kontak erat.
- d. Membuang dahak pada tempat tertutup dan higienis.

Tindakan ini sejalan dengan pedoman kesehatan dan terbukti efektif dalam mencegah penyebaran TB di lingkungan keluarga.

3. Peran dalam Memodifikasi Lingkungan Rumah

Keluarga rutin membuka jendela dan pintu setiap hari untuk memperlancar sirkulasi udara dan memastikan masuknya sinar matahari. Lingkungan yang terang dan berventilasi baik dapat mengurangi keberlangsungan hidup kuman TB.

4. Peran dalam Kontrol Rutin.

Keluarga mendampingi penderita untuk kontrol rutin ke fasilitas kesehatan dan mengambil obat. Dukungan ini sangat penting untuk menjaga kontinuitas pengobatan serta memberikan semangat dan kenyamanan emosional bagi penderita.

5. Peran dalam Mengingat untuk Minum Obat

Keluarga bertindak sebagai pengingat agar penderita rutin mengonsumsi obat sesuai jadwal. Kepatuhan minum obat sangat krusial dalam proses penyembuhan dan mencegah resistensi obat.

6. Peran dalam Memberikan Motivasi.

Keluarga memberikan motivasi moral, seperti dorongan untuk patuh terhadap aturan pengobatan, menghindari kebiasaan buruk (merokok, alkohol), dan menjaga pola hidup sehat. Hal ini membantu membangun sikap positif penderita dalam menghadapi penyakitnya.

Daftar Pustaka

- Adiputra, I. M. S., & Rahayu, K. M. N. (2017). Warm Water Administration Before Nebulization Improves Airway Clearance In Asthma. *Bali Medika Jurnal*, 4(2), 38–49. <https://doi.org/10.36376/bmj.v4i2.3>
- Aja, N., Ramli, R., & Rahman, H. (2022). Penularan Tuberkulosis Paru dalam Anggota Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Siko Kota Ternate. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 18(1), 78. <https://doi.org/10.24853/jkk.18.1.78-87>
- Ali Zaidin H. (2009). *Pengantar Keperawatan Keluarga*. EGC.
- Dary, D., Puspita, D., & Mela, S. K. C. (2018). Peran Keluarga Dalam Merawat Anak Yang Menderita Penyakit Tb Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Getasan. *Link*, 13(2), 5. <https://doi.org/10.31983/link.v13i2.2840>
- Dinkes Sumba Timur. (2016). *Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur*.
- Dinkes Sumba Timur. (2017). *Laporan Dinas Kesehatan Kab Sumba Timur*.
- Dinkes Sumba Timur. (2019). *Laporan Dinas Kesehatan Sumba Timur*.
- Fadila, R. N., & Riono, P. (2014). Pengaruh Rejimen terhadap Ketidakpatuhan Berobat Tuberkulosis. *Kesmas: National Public Health Journal*, 9(2), 107. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v9i2.498>

- Friedman, M. M. (1998). *Keperawatan Keluarga Teori dan Praktik*. EGC.
- Hanida, S. F. (2018). Potensi Tinggi Faktor Lingkungan Fisik dan Biologis Terjadinya Penularan Malaria di Wilayah Kerja Puskesmas Pandean Trenggalek. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(1), 82–91.
- Hardhana, B., Siswanti, T., Sibuea, F., Widiyanti, W., Susanti, M. I., Pangribowo, S., Aprianda, R., Indah, S., Mardiana, R., Sakti, E. S., Wahyudi, T., Habibi, H. A., Sari, D. M., Sigit, B. B., Maslinda, H., & Maula, R. (2018). Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia. *Data Dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia*.
- Hariadi, E., BUSTON, E., NUGROHO, N., & EFENDI, P. (2023). Stigma Masyarakat Terhadap Penyakit Tuberkulosis Dengan Penemuan Kasus Tuberkulosis Bta Positif Di Kota Bengkulu Tahun 2022. *Journal of Nursing and Public Health*, 11(1), 43–50. <https://doi.org/10.37676/jnph.v11i1.4080>
- Jaii. (2010). Upaya Keluarga Dalam Pencegahan Penularan Tuberkulosis (Tb) Paru Ke Anggota Keluarga Lainnya Di Wilayah Kerja Puskesmas Sidorejo Pagaralam Tahun 2010 Prevention of Transmission Efforts Tuberculosis (Tb) Pulmonary in the Other Family Members in Working Are. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 177–187.
- Jaji. (2010). *Upaya keluarga dalam pencegahan penularan Tuberkulosis (TB) paru ke anggota keluarga lainnya di wilayah kerja PUSKESMAS siderjo pagalaran tahun 2010* Jaji. 2–3.
- Jufrizal, Hermansyah, M. (2016). Peran Keluarga Sebagai Pengawas Minum Obat (Pmo) Dengan Tingkat Keberhasilan Pengobatan Penderita Tuberkulosis Paru.

Jurnal Ilmu Keperawatan, 4(1).

Jufrizal, Hermansyah, & Mulyadi. (2016). Peran Keluarga Sebagai Pengawas Minum Obat (PMO) dengan Tingkat Keberhasilan Pengobatan Penderita Tuberkulosis Paru. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 4(1), 1–12.

Kemenkes.RI. (2014). *STRATEGI NASIONAL PENGENDALIAN TB*.

Kemenkes, R. (2020). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis*. 6.

Kemenkes RI. (2014). *Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis*.

Kemenkes RI. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia 2017*.

Kementerian Kesehatan. (2025). *Buku Panduan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Tuberkulosis*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis*. Kementerian Kesehatan RI. https://tbindonesia.or.id/wp-content/uploads/2021/06/UMUM_PNPK_revisi.pdf

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease (Covid-19). In *Kementerian Kesehatan RI* (Revisi Ke-). Kementerian Kesehatan RI. <https://doi.org/10.33654/math.v4i0.299>

Kristanti, H., Sekarwati, N., Studi, P., Bank, T., Stikes, D., & Husada, W. (2017). *KEPATUHAN MINUM OBAT ANTI TUBERCULOSIS DI WILAYAH PUSKESMAS JETIS 1 , BANTUL Description Of Family Support And Self-Motivation Concerning Anti-Tuberculosis Drugcompliance Level In Jetis 1 Health Center , Bantul Tuberkulosis Indonesia berada di posisi empa*.

- Kristinawati, B., Muryadewi, A., & Irianti, A. D. (2020). The Role of Family as A Caregiver in Caring for Family Members that are Suffering from Pulmonary Tuberculosis. *Jurnal Ners*, 14(3), 362. <https://doi.org/10.20473/jn.v14i3.17214>
- Kristini, T., & Hamidah, R. (2020). Potensi Penularan Tuberculosis Paru pada Anggota Keluarga Penderita. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(1), 24. <https://doi.org/10.26714/jkmi.15.1.2020.24-28>
- Lailatul, N., Rohmah, S., & Wicaksana, A. Y. (2015). Upaya Keluarga untuk Mencegah Penularan dalam Perawatan Anggota Keluarga dengan TB Paru. *Jurnal Keperawatan*, 6(2), 108–116.
- Lukman, S. (2024). Buku Ajar Keperawatan Keluarga. In *Buku Ajar Keperawatan Keluarga*. <https://doi.org/10.36590/penerbit.salnesia.5>
- Maria H. Bakri. (2018). *Asuhan keperawatan Keluarga*. Pustaka Mahardika.
- Nazhofah, Q., & Ella Nurlaella Hadi. (2022). Dukungan Keluarga terhadap Kepatuhan Pengobatan pada Pasien Tuberculosis : Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 5(6), 628–632. <https://doi.org/10.56338/mppki.v5i6.2338>
- Noviana, L., Nasution, S. Z., & Wahyuni, A. S. (2023). Dukungan Keluarga terhadap Kepatuhan Minum Obat pada Penderita Tuberculosis dengan Multidrug Resistant (TB-MDR). *Journal of Telenursing (JOTING)*, 5(2), 1650–1658. <https://doi.org/10.31539/joting.v5i2.6530>
- Nugroho Adhi Randy. (2011). Studi Kualitatif Faktor Yang Melatarbelakangi Drop Out Pengobatan Tuberkulosis Paru. *KESMAS - Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 83–90. <https://doi.org/10.15294/kemas.v7i1.2801>

- Ridwan Setiawan. (2016). *Teori dan Praktek Keperawatan*. Unnes Pres.
- Siallagan, S., Suriany, R., & Ernauli, S. (2024). *HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT OAT PADA PASIEN TUBERKULOSIS (TBC) DI RS CIBITUNG MEDIKA TAHUN 2023*. 5(2020), 1–10.
- Siti Riskika dkk. (2021). Family nursing. In *Frontier Nursing Service quarterly bulletin* (Vol. 46, Issue 1). Duta Media Publishing. <https://doi.org/10.1097/00000446-198787020-00037>
- Smeltzer, Suzanne C. dan Bare, B. G. (2002). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner dan Suddarth* (Edisi 8). EGC.
- Sri Hardina, Septiyanti, D. W. (2019). PENGARUH KONSUMSI AIR HANGAT TERHADAP FREKUENSI NAFAS PADA PASIEN ASMA DI PUSKESMAS SUKAMERINDU KOTA BENGKULU TAHUN 2019. *Journal of Nursing and Public Health*, 7(2), 77–86. <https://doi.org/10.37676/jnph.v7i2.901>
- Suprajitno. (2004). *Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi Dalam Praktek*. EGC.
- Susilo, A. (2010). Asuhan Keperawatan Keluarga. In *Fakultas Ilmu Kesehatan Ump* (Issue 2010). EGC. <http://repository.ump.ac.id/2753/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. (1992). *Undang-Undang*, 1–42. [https://doi.org/10.1016/S0040-4039\(02\)00817-1](https://doi.org/10.1016/S0040-4039(02)00817-1)

Wahdi, A., & Puspitosari, D. R. (2021). Mengenal Tuberkulosis. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 23–24.



Glosarium

A

- ART (Antiretroviral Therapy): Terapi untuk mengendalikan infeksi HIV/AIDS.
- Anatomi: Ilmu yang mempelajari struktur tubuh makhluk hidup.

B

- Bakteriologis: Terkait dengan pemeriksaan atau analisis bakteri.
- Basil Tahan Asam (BTA): Bakteri penyebab TB yang dapat bertahan terhadap pewarnaan asam, contohnya *Mycobacterium tuberculosis*.
- BCG (Bacillus Calmette-Guérin): Vaksin untuk mencegah TB berat pada anak.

D

- Droplet nuclei (Percik renik): Partikel kecil berisi bakteri yang dikeluarkan melalui batuk/bersin penderita TB dan melayang di udara.

E

- Efusi Pleura: Penumpukan cairan di rongga pleura (sekitar paru-paru), salah satu komplikasi TB.
- Ekstraparu: Istilah untuk TB yang menyerang organ selain paru-paru, seperti tulang, kelenjar getah bening, otak, dll.

F

- Fenotip: Karakteristik yang tampak dari suatu organisme, dalam konteks ini, metode mendeteksi resistensi obat TB.

G

- Gejala Klinis: Tanda atau keluhan yang dirasakan oleh pasien.

H

- HIV (Human Immunodeficiency Virus): Virus yang menyerang sistem imun tubuh dan dapat mempengaruhi perkembangan TB.

I

- Infeksi: Masuk dan berkembangnya mikroorganisme patogen di dalam tubuh.
- Intradermal: Cara pemberian obat atau vaksin melalui lapisan kulit.

K

- Kambuh (Relaps): Kembalinya penyakit setelah pasien dinyatakan sembuh.
- Kultur: Teknik menumbuhkan bakteri di media khusus untuk mendeteksi keberadaannya.
- Kuman Persister: Kuman yang bertahan dalam tubuh meskipun jumlahnya sedikit dan tidak aktif, berisiko menyebabkan kambuh.

L

- Lesi: Kerusakan jaringan tubuh akibat penyakit.
- Lini pertama: Obat TB utama yang digunakan dalam pengobatan standar.

M

- Mediastinum: Ruang tengah di antara paru-paru yang berisi jantung dan organ lainnya.
- Milier: Bentuk TB parah yang menyebar melalui aliran darah dan menyebabkan lesi kecil di banyak organ.
- MOTT (Mycobacterium Other Than Tuberculosis): Jenis bakteri mirip TB yang dapat menginfeksi manusia tetapi bukan *Mycobacterium tuberculosis*.
- *Mycobacterium tuberculosis*: Bakteri penyebab utama TB.

O

- Obat Anti Tuberkulosis (OAT): Obat yang digunakan untuk mengobati infeksi TB.

P

- Parenkim Paru: Jaringan utama paru-paru tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
- Pasien Baru: Pasien yang belum pernah menjalani pengobatan TB sebelumnya.
- Putus Berobat (Loss to follow-up): Kondisi ketika pasien menghentikan pengobatan TB selama ≥ 2 bulan berturut-turut.

R

- Resistensi Obat: Ketidakmampuan obat untuk membunuh bakteri karena bakteri telah beradaptasi.
- Rifampisin: Salah satu obat lini pertama utama dalam pengobatan TB.

S

- Sistem Imun: Sistem kekebalan tubuh yang melindungi dari infeksi.

T

- TB MDR (Multi Drug Resistant): TB yang kebal terhadap dua obat utama (isoniazid dan rifampisin).
- TB XDR (Extensive Drug Resistant): TB yang kebal terhadap banyak obat, termasuk lini kedua.
- Tahap Awal dan Tahap Lanjutan: Dua fase penting dalam pengobatan TB.
- TBC (Tuberkulosis): Singkatan umum dari penyakit Tuberkulosis.

Profil Penulis



Domianus Namuwali, S.Kep., Ns., M.Kep

Penulis lahir di Mandas pada 24 Agustus 1978. Mengawali pendidikan keperawatan dari SPK Waingapu (1998), melanjutkan D-III Keperawatan Waingapu (2005), kemudian meraih gelar Sarjana Keperawatan dan profesi Ners dari Universitas Diponegoro Semarang (2010). Gelar Magister Keperawatan diperoleh dari universitas yang sama pada tahun 2016. Karier keperawatan dimulai sebagai perawat pelaksana di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu (1999–2000), lalu bertugas di Puskesmas Tana Rara (2000–2005) dan Puskesmas Kombapari (2005–2006). Sejak 2006, penulis berkiprah sebagai tenaga pengajar di Program Studi Keperawatan Waingapu hingga 2021, kemudian menjadi dosen di Prodi Pendidikan Profesi Ners Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang sejak 2022 hingga sekarang. Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keluarga, Gerontik, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan. Aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan organisasi PPNI, penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris dan Wakil Ketua DPD PPNI Sumba Timur, serta saat ini sebagai Ketua Divisi Organisasi dan Kaderisasi DPW PPNI NTT. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail domianus2012@gmail.com

Profil Penulis



Maria Kareri Hara, S.Kep.,Ns.,M.Kes.

lahir di Kondamara, kecamatan lewa, sumba Timur, NTT tanggal 10-02-1967, pendidikan ;Lulus Sekolah perawat kesehatan Depkes Waingapu tahun 1988, tamat DIII keperawatan keguruan di AKPER TIDUNG Ujung Pandang tahun 1996, Tamat S1 Keperawatan dan ners tahun 2003 UNAIR Surabaya, menyelesaikan pendidikan S2 Ilmu kesehatan masyarakat pada Fakultas kedokteran Universitas Udayana tahun 2013. Awal karier sebagai perawat di RSUD TC Hillers Maumere 1990 – 1996, tahun 1997 – 2000 sebagai guru SPK Depkes di Kabupaten sumba Timur, pada tahun 2003 sebagai dosen di Poltekkes kemenkes Kupang Program studi keperawatan sumba Timur waingapu. Tahun 2009 -2011 sebagai ketua program khusus di sumba barat, kemudian tahun 2018 Sebagai ketua prodi keperawatan waingapu sumba timur sampai sekarang. Pengalaman Organisasi, sebagai ketua PKK kecamatan pandawai tahun 2011 -2014, sebagai anggota dan penasehat PPNI tahun 2018 sd sekarang. Aktif juga sebagai ketua komisi lanjut usia, aktif dalam pengabmas dan penelitian

Profil Penulis



Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep

Penulis yang akrab dipanggil Willy ini lahir di Malaka-NTT, 27 Mei 1972. Memiliki Riwayat Pendidikan: Akper PEMDA Kupang, tamat tahun 1996, Ners Unair tamat tahun 2004, S2 Keperawatan Unair, tamat tahun 2010, S3 Keperawatan UI, tamat tahun 2023. Penulis sebagai staf dosen tetap pada program studi PPN Poltekkes Kemenkes Kupang. Riwayat organisasi: sebagai Ketua DPW PPNI Provinsi NTT, Anggota Bidang Diklat DPP PPNI, Anggota Bidang V Kolegium Keperawatan Indonesia. Email Penulis: aemilianusmau58@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas secara mendalam bagaimana peran aktif keluarga sangat penting dalam mendukung perawatan penderita Tuberkulosis Paru (TB Paru). Berlandaskan teori dan hasil penelitian terbaru, buku ini menggarisbawahi bahwa keluarga inti — terutama pasangan dan anak-anak — memegang kunci dalam proses penyembuhan penderita, baik secara fisik, psikologis, sosial, hingga dalam aspek pencegahan penularan penyakit.

Disusun dengan pendekatan kualitatif dan didukung oleh wawancara dengan keluarga pasien TB Paru, buku ini menjelaskan beberapa bentuk kontribusi nyata yang dilakukan keluarga. Mulai dari membantu meredakan gejala batuk dengan pemberian air hangat, mendukung kontrol rutin ke fasilitas kesehatan, mengingatkan konsumsi obat secara teratur, hingga memodifikasi lingkungan rumah untuk mencegah penularan.

Lebih lanjut, buku ini menguraikan strategi keluarga dalam menjaga kebersihan dan keselamatan bersama, seperti penggunaan masker, pemisahan alat makan, tidur terpisah, dan pembuangan dahak yang higienis. Tidak hanya itu, aspek psikososial pun dibahas, termasuk bagaimana keluarga memberi motivasi, nasihat, dan perhatian emosional agar penderita tetap semangat dan patuh dalam menjalani terapi.

Buku ini menjadi sumber bacaan penting bagi tenaga kesehatan, mahasiswa keperawatan atau kedokteran, serta masyarakat umum yang ingin memahami pentingnya peran keluarga dalam mengatasi penyakit menular seperti TB Paru. Penulis berhasil menunjukkan bahwa keberhasilan pengobatan tidak hanya bergantung pada medis, tetapi juga dukungan kuat dari lingkungan terdekat: keluarga.

Buku ini membahas secara mendalam bagaimana peran aktif keluarga sangat penting dalam mendukung perawatan penderita Tuberkulosis Paru (TB Paru). Berlandaskan teori dan hasil penelitian terbaru, buku ini menggarisbawahi bahwa keluarga inti — terutama pasangan dan anak-anak — memegang kunci dalam proses penyembuhan penderita, baik secara fisik, psikologis, sosial, hingga dalam aspek pencegahan penularan penyakit.

Disusun dengan pendekatan kualitatif dan didukung oleh wawancara dengan keluarga pasien TB Paru, buku ini menjelaskan beberapa bentuk kontribusi nyata yang dilakukan keluarga. Mulai dari membantu meredakan gejala batuk dengan pemberian air hangat, mendukung kontrol rutin ke fasilitas kesehatan, mengingatkan konsumsi obat secara teratur, hingga memodifikasi lingkungan rumah untuk mencegah penularan.

Lebih lanjut, buku ini menguraikan strategi keluarga dalam menjaga kebersihan dan keselamatan bersama, seperti penggunaan masker, pemisahan alat makan, tidur terpisah, dan pembuangan dahak yang higienis. Tidak hanya itu, aspek psikososial pun dibahas, termasuk bagaimana keluarga memberi motivasi, nasihat, dan perhatian emosional agar penderita tetap semangat dan patuh dalam menjalani terapi.

Buku ini menjadi sumber bacaan penting bagi tenaga kesehatan, mahasiswa keperawatan atau kedokteran, serta masyarakat umum yang ingin memahami pentingnya peran keluarga dalam mengatasi penyakit menular seperti TB Paru. Penulis berhasil menunjukkan bahwa keberhasilan pengobatan tidak hanya bergantung pada medis, tetapi juga dukungan kuat dari lingkungan terdekat: keluarga.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-10-9633-7



9

786231

098337